

Nome:	MATTEO
Cognome:	FUSER
Reparto:	Centro Trials
Data di nascita:	24/10/2022
Nosologico:	 2026064744

Lettera di dimissione

Documento creato il 06/10/2026 - 11:41 da IMONDI CHIARA
Ultimo aggiornamento del 06/10/2026 - 11:41 da: IMONDI CHIARA - Versione n° 1

Ai genitori/tutore ed al medico curante di MATTEO FUSER.

MATTEO FUSER, nato a VITERBO il 24/10/2022, viene dimesso dall'UO DH Centro Trials in data 06/10/2026.
MATTEO è stato ricoverato in data 06/10/2026 in regime di Day Hospital presso il reparto di DH Centro Trials con la seguente ipotesi diagnostica all'accettazione:
Paralisi cerebrale infantile
Partecipazione a studio clinico sperimentale

Anamnesi:

Anamnesi:

Paziente di 3 anni e 11/12, di sesso maschile, razza bianca ed etnia caucasica affetto da doppia emiparesi e ritardo dello sviluppo psicomotorio in paziente con storia di sofferenza pre/ perinatale (diagnosi a Febbraio 2024).

Anamnesi familiare: Unicogenito. Madre con trombofilia (fattore II eterozigote, MTHFR c677T omozigote, MTHR c.1286A>C assente, Fattore V c.1601G>A assente. Omocisteina elevata). Padre con trombofilia (MTHFR c.77 eterozigote, MTHFR c.1286 eterozigote. Fattore II assente, Fattore V assente.) Cugino del padre con pregresso arresto cardiaco a 18 anni.

Anamnesi fisiologica e patologica remota: I gravidanza decorsa con minaccia di parto pretermine alla 29a settimana, somministrata eparina per trombofilia. Parto: spontaneo a 38 settimane + 4 gg, peso neonatale 3146 g, pianto subito valido (Apgar 9-10). Non segni di sofferenza peri-post natali. Riscontro di ittero in 5° giornata di vita, trattato con fototerapia.

Riferita acquisizione del controllo del capo intorno ai 3 mesi, con tendenza ad inclinarlo verso l'emilato sinistro, acquisizione del controllo del tronco intorno agli 8 mesi, deambulazione autonoma acquisita all'età di 30 mesi. Sviluppo neurolinguistico caratterizzato da prime parole intorno ai 12 mesi, successiva evoluzione lenta, tutt'ora linguaggio limitato a poche parole.

Ritmo sonno veglia caratterizzato da frequenti risvegli notturni (2-3 volte a notte), con pianto, della durata di 5-10 minuti e talvolta con necessità di cosleeping.

Ad Agosto 2023 presa in carico presso la ASL di Viterbo, avviata terapia riabilitativa: 2 sedute di fisioterapia e 1 seduta di psicomotricità a settimana.

A Settembre 2023 visita oculistica (refrazione ipermetropica) con FOO (nei limiti), si consigliavano esercizi per facilitare la motilità oculare e controllo a 6 mesi.

A 15 mesi somministrate Griffiths III dalla quale emergeva un'età equivalente di sviluppo pari a 11 mesi, a fronte di un'età cronologica di 15 mesi (quoziente di sviluppo 70), con caduta specifica nell'area grosso motoria.

Trombofilia, Fattore V assente, Fattore II eterozigote, MTHFR C677T in eterozigosi.

A Febbraio 2024, durante ricovero in Neurologia dello Sviluppo, eseguita RM encefalo: i reperti descritti appaiono compatibili con quadro di leucomalacia periventricolare verosimilmente in esiti pregressa sofferenza ipossico-ischemica. In considerazione del dato anamnestico di gravidanza complicata da funneling cervicale e contrazioni precoci e del quadro radiologico, il noto ritardo del neurosviluppo appariva inquadrabile come ritardo dello sviluppo psicomotorio prevalentemente nell'area grosso motoria da esiti ipossico-ischemici pre/ perinatali.

EEG nei limiti della norma.

Contestuale valutazione ematologica: trombofilia in caso di eventi a rischio trombotico da valutare profilassi/terapia anticoagulante/antiaggregante.

A tale proposito, a Dicembre 2025, in seguito al riscontro di valori ridotti di acido folico, veniva avviata profilassi con Folium 15 gtt al giorno per un mese ogni tre mesi.

Veniva quindi preso in carico presso la UOC di Neuroriabilitazione della Sede di Santa Marinella, presso la quale effettua follow-up periodico.

Ultima valutazione in regime di Day-Hospital presso tale sede in data 22/06/2026.

Ultimo ricovero presso il Reparto UDGE SM per rivalutazione del PRI e training intensivo a Novembre 2025 con diagnosi di

Nome:	MATTEO
Cognome:	FUSER
Reparto:	Centro Trials
Data di nascita:	24/10/2022
Nosologico:	 2026064744

doppia emiparesi e ritardo dello sviluppo psicomotorio in paziente con storia di sofferenza pre/perinatale. Nel corso del ricovero effettuato inoculo di tossina botulinica sui muscoli gemelli mediale e laterale (20 UI x4) bilateralmente. Riferita buona risposta alla tossina.

Effettuata valutazione ambulatoriale con genetista, prescritto approfondimento genetico diagnostico in trios per fattori di predisposizione genetici a eventi vascolari cerebrali (inclusi geni COL4A1 e COL4A2): in corso di refertazione.

Prescritte Ortesi tipo Botter con barra in carbonio + fasce extrarotanti (queste ultime non più utilizzate).

Effettua attualmente trattamento riabilitativo sul territorio: 1 FKT, 2 NPM, 3 logopedia/ sett.

Alimentazione varia e regolare anche per consistenza. Utilizza posate e bicchiere. Raggiunto il controllo sfinterico. Sonno irregolare con risvegli frequenti, no russamento, assunta in passato in maniera discontinua melatonina (non sanno riferire precisamente le date di inizio e sospensione) con scarsi benefici.

Deambula autonomamente senza appoggio dall'età di 30 mesi, con impaccio.

Frequenta il secondo anno di scuola dell'infanzia con sostegno ed educatore aggiunto, con riferito buon adattamento.

Non note allergie.

Effettuate vaccinazioni secondo calendario di legge + anti-Rotavirus.

Effettua terapia inalatoria di fondo tramite distanziatore con beclometasone dipropionato (Clenil plus) 1 puff/die a Settembre-Ottobre, poi 2 puff/ die da Novembre a Febbraio, poi 1 puff/ die da Marzo e Giugno, poi sospende i mesi estivi da Giugno ad Agosto a scopo profilattico per bronchite asmatiforme (terapia prescritta dal 30/12/2024 e tutt'ora in corso).

Assunta sino a Giugno 2026 ed attualmente sospesa nel periodo estivo profilassi con Di-Base gocce 10.000 UI, 2 gtt/die.

Ripresa stabilmente terapia con Melatonina (Melamil tripto) 1 mg/die da Giugno 2026.

In data odierna accede per essere sottoposto a Screening Visit/V1 per lo studio NGF-CP-201 (PI Staccioli).

Toma in data odierna per effettuare RMN encefalo nell'ambito della visita di screening/V1 per lo studio NGF-CP-201.

Dall'ultimo controllo non riferiti sAE, AEs o CMs.

Terapie attualmente in corso:

- Folium 15 gtt al giorno per un mese ogni tre mesi per profilassi di trombofilia e pregresso riscontro di ridotti valori di acido folico da Dicembre 2025 sino a Febbraio 2025 (poi sospesa autonomamente dai genitori).

- Terapia inalatoria di fondo tramite distanziatore con beclometasone dipropionato (Clenil plus) 1 puff/die a Settembre-Ottobre, poi 2 puff/die da Novembre a Febbraio, poi 1 puff/die da Marzo e Giugno, poi sospende i mesi estivi da Giugno ad Agosto a scopo profilattico per bronchite asmatiforme (terapia prescritta dal 30/12/2024 e tutt'ora in corso).

- Assunta sino a Giugno 2026 ed attualmente sospesa nel periodo estivo profilassi con Di-Base gocce 10.000 UI, 2 gtt/die.

- Ripresa stabilmente terapia con Melatonina (Melamil tripto) 1 mg/die da Giugno 2026.

Precedenti ricoveri:

UDGEE SM

Esame obiettivo:

Rilevazione del 06-10-2026 ore 09:18:25

Parametri Vitali ed Auxologici

Peso: 17 Kg - Altezza: 107,3 cm - Circonferenza Cranica: 52 cm

FC: 92 battiti/min - FR: 20 atti/min - PA max: 106 mmHg - PA min : 62 mmHg

Condizioni generali: Buone

Sensorio: Vigile

Cute e Mucose: Cute: Cute e mucose rosee e normoidratate.

Capo: Nulla da rilevare

Apparato Locomotore: Nulla da rilevare

Apparato Cardio Circolatorio: Frequenza cardiaca: 89 battiti/min;

PA max: 104 mmHg;

PA min: 73 mmHg;

Perfusione tempi di refill capillare: ≥ 3 s

Ritmo: Ritmico

Rumori cardiovascolari: Attività cardiaca ritmica, toni netti.

Firmato da: IMONDI CHIARA - Data e ora della firma: 06/10/2026 11:41:37

Nome:	MATTEO
Cognome:	FUSER
Reparto:	Centro Trials
Data di nascita:	24/10/2022
Nosologico:	 2026064744

Apparato Respiratorio: Torace: Buona penetrazione d'aria su tutto l'ambito polmonare. Non rumori aggiunti.
Frequenza respiratoria: 20 atti/min;

Sistema Gastrointestinale: Addome: Addome piano, trattabile, non dolente né dolorabile alla palpazione diffusamente.

Sistema Nervoso: Tono muscolare:

Note aggiuntive: Quadro posturomotorio di doppia emiparesi spastica con maggiore compromissione emilato sinistro. Alla mobilizzazione passiva lieve limitazione nell'escursione articolare alla caviglia bilateralmente, riducibile. Deambulazione autonoma con appoggio sull'avampiede (che si corregge se il bambino viene richiamato), ginocchia in flessione e intrarotazione degli arti inferiori; agli arti superiori tendenza alla flessione del gomito. MAS caviglia sinistra 3; PROM caviglia sinistra 104°; Gross Motor Classification System: II. No retrazioni articolari. No distonie.

Apparato genitale: Genitali esterni: Maschili
Genitali esterni prepubere (Tanner I).

Terapia effettuata durante il ricovero:

Terapia	Principio attivo / Farmaco Reale	Indicazioni
Giornaliera	beclometasone dipropionato 0.8 mg (2 ml) [aerosol, sospensione per nebuliz]	Dose: 1 puff Alle: 22:00
Giornaliera	melatonina relax 1mg	Dose: 1 mg Alle: 22:00

Esami di laboratorio:

*=Esame ripetuto

Esami in attesa di refertazione: Si

Altro

RM encefalo in sedazione profonda senza MDC

Epicrisi e conclusioni:

Matteo è un bambino di 3 anni e 11/12 affetto da paralisi cerebrale infantile a fenotipo spastico, giunto in DH a digiuno e in buone condizioni generali per effettuare RM encefalo in sedazione profonda e senza MDC prevista dallo Studio clinico sperimentale NGF-CP-201 (PI Staccioli) in cui è arruolato con ID 039-002-005.

Riferita sostanziale stabilità clinica dall'ultima visita. Non eventi avversi o modifiche delle concomitant medications.

Rilevati parametri antropometrici e parametri vitali dopo 5 minuti di riposo, nella norma/ncs.

Effettuato esame obiettivo generale e neurologico (quest'ultimo invariato rispetto alla Screening visit del 30/09/2026).

Eseguita quindi RM encefalo in sedazione con Sevoflurane inalatorio 2.0% dalle 08:30 alle 09:36.

Terminata la procedura il paziente è rientrato in reparto in buone condizioni generali. Si è reidratato e rialimentato per os al completo risveglio, senza complicanze. Rilevati parametri vitali, sempre nella norma/ncs.

Nessuna problematica in corso di osservazione.

Si dimette stabile in buone condizioni generali con programma di follow-up.

Diagnosi alla dimissione:

Paralisi cerebrale infantile

Partecipazione a studio clinico sperimentale

Prescrizioni:

Prosegue al momento terapia domiciliare invariata.

Prossimi controlli:

Prossimi appuntamenti di studio:

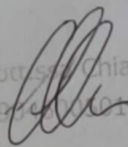
Nome:	MATTEO
Cognome:	FUSER
Reperto:	Centro Trials
Data di nascita:	24/10/2022
Nosologico:	 2026064744

- Appuntamento per Baseline Visit in data 28/10/2026 alle h h 08:00 a digiuno da solidi da almeno 8 ore e da liquidi chiari da almeno 2 h presso il Centro Trials, Sede del Gianicolo Padiglione Salviati piano 1.

Contatti Centro Trials: email ctc@opbg.net; tel 066859-3072 medicheria o -2339/-3077 stanza medici.

U. O. C. Trials
Responsabile U. O. C. Dott.ssa Marina Vivarelli
Tel. (+39) 06.6859.3072

Mail: ctc@opbg.net


Dott.ssa Chiara Imondi
974010019931174